

## • 临床案例 •

## 华法林的药物相互作用案例分析

孟菲

【摘要】 目的 了解华法林与其他药物的相互作用。方法 通过总结分析 1 例应用华法林的房颤患者的诊治经过、用药情况。结果 华法林与较多药物如头孢哌酮舒巴坦钠、氟康唑等存在较严重的相互作用。结论 临床上使用华法林时应格外重视,并加强监测。

【关键词】 华法林; 相互作用; 不良反应; 案例分析

华法林是香豆素类口服抗凝血药,主要用于血栓栓塞性疾病,还可用于房颤患者、心脏瓣膜置换术后、心肌梗死后的抗凝治疗。在临床使用过程中华法林与许多药物、食物同服都会产生相互作用,影响华法林的抗凝作用,同时容易引起不良反应,甚至导致死亡。本文通过具体案例,来阐述华法林与其他药物的相互作用,以期引起广大医药工作者的重视。

## 1 患者基本情况与特点

患者徐某,女,82 岁,主因“肺内占位 2 年余,间断头晕 1 周”于由门诊入院。患者既往有高血压病 30 年,间断胸闷近 6 年,自服硝酸甘油等治疗可好转,近 2 年未予规律诊治;房颤病史 20 余年,未规律诊治,现服用华法林 4.5 mg;否认糖尿病、血脂异常及溃疡病史。否认肝炎、结核病史,否认外伤、重要药物应用史及输血史。

体格检查:生命体征平稳,双肺呼吸音清,未闻及干湿啰音,心音强弱不等,心律绝对不齐,心率 88 次/min,各瓣膜听诊区未闻及病理性杂音。

入院诊断:肺内占位待查;高血压;房颤。

## 2 病程及治疗过程

患者入院后将相关检查考虑肿瘤可能性大,并伴有高血压、脑供血不足可能。给予阿司匹林抗血栓,华法林抗凝,纤溶酶、前列地尔、丹参酮 II A 磺酸钠注射液等扩血管抗血栓治疗,并福辛普利、酒石酸美托洛尔降血压,地高辛强心,螺内酯利尿,核糖核酸提高免疫治疗。入院时查 INR 值为 4.57,于入院第四天停用华法林,并于入院第六天加用头孢哌酮舒巴坦钠抗感染。期间多次监测 INR 值,入院第十天时 INR 值降至 1.54,再次应用华法林 3.0 mg/d,并低分子肝素治疗。入院第十九天,INR 值调整至 2.68。至入院第二十天患者咳嗽喘息加重,查体闻及两肺散在湿啰音,复查胸片提示右上肺阴影,考虑阻塞性肺炎,病原菌考虑为细菌及真菌感染,给予头孢哌酮舒巴坦钠及氟康唑治疗,并给予氯雷他定、孟鲁司特、氨溴索祛痰治疗,降压药改为厄贝沙坦氢氯噻嗪联合硝苯地平。至入院第二十六天,患者喘息加重,伴有夜间平卧困难,心音强弱不齐,心律绝对不齐,心律 75~85 次/min,右下肢浮肿。考虑心衰可能性大,给予硝酸异山梨酯、呋塞米等治疗。至第二十七天,复查 INR 值达到 12.28,病情加重,血氧饱和度下降,气管插管时吸痰为血性分泌物,考虑出血。咨询临床药师后,停用华法林并给予冰冻血浆、维生素 K<sub>1</sub> 注射液后,次日 INR 值降至 2.60。其中入院第十五天、二十八天两次监测肝功能,指标正常。

## 3 药物治疗方案分析

患者为老年女性,因“肺内占位 2 年余,间断头晕 1 周”为主诉入院,入院后在积极检查以明确肺内占位原因的同时,积极给予降血压、抗凝、强心利尿等治疗。根据《心房颤动的诊断与药物治疗》(中国专家共识)<sup>[1]</sup>,本例患者为房颤、高血压患者,根据危险因素分层,可单用华法林抗凝,INR 值目标为 2.0~3.0。但本例病例中却给予多种抗凝药物如低分子肝素、华法林;抗血小板药物如阿司匹林;抑制血小板聚集、抗血栓的药物如前列地尔、纤溶酶、丹参酮 II A 磺酸钠、纤溶酶等。使出血风险急剧增加,治疗方案欠妥。

本例患者入院前已服用华法林 4.5 mg,1 次/d,经询问无特殊不适。入院第二十天时 INR 值开始升高,至第二十七天时 INR 值达 12.28,并出现出血。根据影响 INR 值的影响因素<sup>[2]</sup>分析,可基本排除遗传因素、疾病因素以及生理、精神刺激等相关因素,考虑与药物相互作用可能性大。患者住院期间的治疗用药较多,能与华法林产生相互作用的亦较多。阿司匹林、低分子肝素、螺内酯、头孢哌酮舒巴坦钠、氟康唑、亚胺培南西司他丁钠、布地奈德均与之有相互作用<sup>[3]</sup>。阿司匹林、低分子肝素、螺内酯、头孢哌酮舒巴坦钠、布地奈德为入院二十日时起新增加使用的药物。其中头孢哌酮舒巴坦钠、氟康唑均可增强华法林的抗凝效果,使 INR 值升高。相互作用级别为:中度及中度以上相互作用<sup>[3]</sup>。布地奈德为糖皮质激素类药物,可增加血液凝固性,小剂量时可拮抗抗凝剂的作用,大剂量使用会引起 INR 值明显升高。药物相互作用级别为:中度及中度以上。本例病例中布地奈德剂量一日给药剂量为 1000 μg,给药途径为雾化吸入局部用药。药物剂量较小,可视为拮抗华法林的抗凝作用。综合以上分析,认为本例患者 INR 值突然升高,可认为与氟康唑、头孢哌酮舒巴坦钠、布地奈德的增加使用有关。

在药学监护时,需要密切监测患者的心电图、INR 值等检查结果以及头晕等症状以评价药物的治疗效果,同时也需要特别关注患者是否存在皮肤、牙龈以及其他部位出血等状态,同时检查肾功能以了解是否存在药物的不良反应等,其中 INR 值是重要的监测指标<sup>[4]</sup>。监测频率大致为初开始治疗时第 1 周至少查 3 次 INR,1 周后改为每周 1 次,直到第 4 周,INR 值达到目标值并稳定后每 4 周查一次 INR,剂量调整后重新监测 INR 值<sup>[5]</sup>。本例患者 INR 的监测频率为:入院第十四日(用药 3 d)、入院第十九日(用药 8 d)、入院第二十一日(用药 10 d)、入院第二十七日(用药 16 d)。在用药第 1 周内仅监测 1 次,至用药第 8 天达到目标范围,用药第 10 天达到稳定后改为 1 周监测 1 次,监测频率较低。同时需要注意的是,本例病例在入院二十日时停用多种药物如阿司匹林、低分子肝素等,并新增加了多种药物,都可能影响华法

作者单位:450000 河南中医学院第一附属医院药学部

林的抗凝作用,需要密切监测 INR 的变化,1 周 1 次的监测显然监测频率不足。

至入院第二十七天,患者 INR 值高达 12.28,并伴有出血,危险程度较高。给予本例患者的处理为先停用华法林,并输注冰冻血浆 400 ml/d(患者体重为 78 kg,冰冻血浆用量不足<sup>[3]</sup>),并给予维生素 K<sub>1</sub> 10 mg 静脉推注(20 min)以拮抗华法林的作用。并监测 INR 值,仍较高。遂继续给予冰冻血浆和维生素 K<sub>1</sub>(静脉推注,肌内注射)。至 INR 值降低至 2.60 时停止。在使用以上方法的同时应充分考虑原发病,即血栓形成的风险。同时需要注意的是给予大剂量的维生素 K<sub>1</sub> 时,可导致接下来的 1 周内出现华法林抵抗。本例患者两日内给予应用维生素 k<sub>1</sub> 4 次(40 mg),给以后应用华法林带来麻烦,可考虑增加冰冻血浆的用量,减少维生素 k<sub>1</sub> 的用量。

4 讨论

作为临床药师,在参与临床治疗过程中,对于应用华法

林的病例应特别关注,对于存在药物相互作用的,要提醒医师注意,注意华法林剂量的调整,及时监测 INR 值的变化。在出现 INR 值超出治疗范围时,分析可能的影响因素,并尽可能减少影响,并及时给予医师合理的用药建议。在 INR 值超出治疗范围,且伴有出血等情况,应提供警惕,并及时准确地处理。

参考文献

[1] 杨进刚. 心房颤动的诊断与药物治疗(中国专家共识). 心脑血管病防治,2008,8(4):215-222.  
[2] 葛卫红. 华法林抗凝治疗临床药师指导手册. 人民卫生出版社,2009:5-15.  
[3] 孟菲. 17 例房颤患者应用华法林的药物治疗案例分析.  
[4] 张石革. 抗凝血药与抗血小板药治疗的药学监护. 中国药房,2010,21(10):944-947.

以咳嗽为首发症状的多发肝脓肿 1 例

王春波

肝脓肿起病较急,首发症状主要是寒战、高热、肝区疼痛和肿大,体温可达,伴恶心、呕吐、食欲不振和周身乏力。肝区钝痛或胀痛多属于持续性,有的可伴有右肩部牵涉痛,右下胸及肝区叩击痛,肿大的肝脏有压痛,如果脓肿位于肝脏前下缘比较浅部位时,可伴有右上腹肌紧张和局部明显触痛,严重时或并发于胆道梗阻时,可出现黄疸,比较罕见的首发症状是咳嗽。现将以咳嗽为首发症状的多发肝脓肿 1 例报告如下。

1 资料与方法

患者男性,64 岁,以"间断咳嗽 1 个月,发热 6 d"为主诉而在呼吸科住院治疗,患者既往有高血压病史 2 年,血压波动于 140~150/90~100 mm Hg 左右,未予口服降压药物,否认糖尿病、冠心病病史;否认吸烟史。该患者 1 个月前无明显诱因出现刺激性咳嗽,干咳,伴有阵发性加剧,无明显咳痰,曾就诊于当地社区,胸透未见明显异常,血常规正常,诊断"慢性咽炎",给予"吴太咽炎片"口服,咳嗽症状无明显缓解,未进一步系统诊治。入院前 6 d 患者出现寒战、发热,体温最高达 40℃,应用退热药物后,体温暂时性下降,但体温仍在 37.5℃ 以上,体温降而复升,肺部 CT 回报双肺多发结节样病变,未见明显的炎症影像,血常规提示白细胞 11.1 × 10<sup>9</sup>/L,中性粒细胞百分比 74%,红细胞 3.8 × 10<sup>12</sup>/L,血红蛋白 115 g/L,血小板 120 × 10<sup>9</sup>/L,为系统诊治入院治疗,患者病程中无腹痛、腹泻,无胸闷、胸痛,无咯血,无恶心、呕吐,无头晕、头痛,入院前 1 周饮食睡眠欠佳,二便正常。入院时查体:体温 38.5℃,脉搏 86 次/min,呼吸 18 次/min,血压 85/60 mm Hg,一般状态尚可,神情语明,营养中等,表情自如,自动体位,查体合作,周身皮肤无黄染,浅表淋巴结未触及肿大,颈静脉无充盈,口唇无发绀,球结膜无充血水肿,咽部无充血,双侧扁桃体无肿大,双肺呼吸音清,未闻及明显的干湿罗音,心音有力律齐,未闻及杂音,腹软,剑突下轻压痛,无反

跳痛及肌紧张,肝脾肋下未触及,肝区、肾区无叩击痛,移动性浊音阴性,双下肢无浮肿。初步诊断:双肺结节样病变性质待查、休克原因待查。入院后给予心电、血压监护、血氧饱和度监测,血压波动于 80~90/50~60 mm Hg 之间,血氧饱和度波动于 95%~99% 之间,给予羟乙基淀粉立即静脉输液扩容升压治疗,生理盐水 500 ml + 维生素 C 5.0 g 立即静脉输液补液治疗,生理盐水 250 ml + 哌拉西林舒巴坦 5.0 g,2 次/d 静脉输液抗炎治疗,生理盐水 250 ml + 炎琥宁 400 mg,1 次/d 静脉输液抗病毒治疗,盐酸氨溴索 30 mg,3 次/d 口服止咳化痰治疗,经过抗炎、抗病毒、扩容、补液等对症治疗 2 h 后血压较前有所回升,波动于 90~150/50~60 mm Hg 之间,入院后急查肝胆脾胰腹腔 B 超、双肾输尿管膀胱 B 超均未见明显异常,心电图提示窦性心律,正常范围心电图。急诊血淀粉酶 48 U/L,正常,尿淀粉酶 1250 U/L,正常。复查血常规提示白细胞 15.8 × 10<sup>9</sup>/L,中性粒细胞分比 86%,红细胞 3.9 × 10<sup>12</sup>/L,血红蛋白 120 g/L,血小板 210 × 10<sup>9</sup>/L,肾功能、离子、血糖均正常。入院后第二天,患者突发左侧胸痛,主要表现为左侧肩部至左上腹部之间剧烈的持续性的疼痛,性质为胀痛,无烧灼感、压榨感及濒死感,查体双肺呼吸音清,未闻及明显的干湿罗音,心音有力律齐,未闻及杂音,腹部较韧,剑突下压痛较前剧烈,左上腹部轻压痛,无反跳痛,腹肌较前略有紧张,肝脾肋下未触及,肾区叩击痛阴性,肝区叩击痛可疑阳性,急查心电图提示窦性心律,正常范围心电图,较入院时心电图对比无明显动态变化,急查心肌钙蛋白 0.012 ng/ml,正常。心肌酶正常。复查血常规提示白细胞 19.0 × 10<sup>9</sup>/L,中性粒细胞百分比 89%,红细胞 3.9 × 10<sup>12</sup>/L,血红蛋白 125 g/L,血小板 220 × 10<sup>9</sup>/L,血象较前明显升高,数字胸腹联透胸腹未见明显异常。急行上腹部 CT 检查提示肝脏多发脓肿。胆脾胰腹腔未见明显异常。考虑多发肝脓肿继发腹膜炎,患者由呼吸内科转入普外科,行肝脓肿切开引流术,术后继续抗炎对症治疗,15 d 后患者病情好转,无咳嗽、咳痰,无寒战、发热,复查肺部 CT 可见肺部结节影消失,病情好转出院。

作者单位:163458 黑龙江省大庆市让胡路区大庆龙南医院呼吸内科